Autos: 0852178-11.2022.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Andressa Helena Ferrari Menezes
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aforada por ANDRESSA HELENA FERRARI MENEZES em face de UNIMED CAMPO GRANDE/MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Aduz que *"A autora possui plano de saúde com a empresa requerida, conforme faz prova a carteira da referida instituição, através do n°. 0 051 300229700055 7 e contrato anexo (doc. 04), estando plenamente em dia com suas obrigações (desconto direto em folha – doc. 05). Requereu a autora perante o plano de saúde "Bomba Infusora de Insulina e Insumos", prescritos com urgência por sua endocrinologista (doc. 03), porém o pedido foi negado por falta de cobertura, violando assim a boa-fé contratual, por arcar mensalmente a requerente com custas do contrato de plano de saúde e, quando necessitou da execução do contrato, foi negado tal prestação por mera liberalidade da empresa requerida. Ora Excelência, quando se paga continuamente por um serviço de prestação de saúde, presume-se que em algum momento necessitará da assistência e/ou do tratamento contratado. Nesse contexto, cumpre descrever a situação da autora: Atualmente encontra-se com 29 (vinte e nove) anos de idade e fora diagnosticada com doença diabetes tipo 1 (um) insulino-dependente, com total descontrole glicêmico e crises severas de hipoglicemia, necessitando de internações por cetoacidose diabética, bem como sequelas advindas pelo mal controle da doença, conforme claramente exposto em relatório médico (doc. 03). O tratamento tradicional fornecido pelo SUS e que está dentro do rol da ANS não estava surtindo efeito no caso da requerente, com isso mudanças de insulinas foram realizadas, porém sem sucesso em seu quadro clínico, mantendo grande variabilidade glicêmica e hipoglicemias severas, conforme trecho do relatório médico de sua endocrinologista Dra. Ana Carolina Carli de Freitas – CRM/MS 4064 (doc. 03), logo, pedimos vênia trecho para colacionar aos autos: Por tais motivos, com o descontrole total glicêmico e complicações advindas pela doença, a médica endocrinologista que assiste a autora, recomendou EM CARÁTER DE URGÊNCIA o uso da Bomba Infusora de Insulina Medtronic 780G associado ao sensor de glicose como forma de última tentativa ao controle da doença, tendo em vista o RISCO IMINENTE DE MORTE, vejamos: Conforme já mencionado pela endocrinologista especialista Dra. Ana Carolina Carli de Freitas, Andressa possui alta variabilidade glicêmica, hipoglicemias severas e graves, sendo a Bomba de insulina – Pâncreas Artificial indispensável para sua sobrevida, vejamos outros trechos relevantes: Desta feita, concluem-se que os médicos que assistem a autora, em especial a médica endocrinologista Dra. Ana Carolina Carli de Freitas – CRM/MS 4064 (doc. 03), indicam, com URGÊNCIA, a terapia com bomba de insulina e insumos para o tratamento do diabetes no caso da autora. A bomba vai muito além de ser um mecanismo de aplicação de insulina, é um aparelho que exerce a mesma função do pâncreas, dando ao paciente, a possibilidade de controlar sua glicemia e ter uma melhor qualidade de vida, conforme demais explicações além das mencionadas pelas endócrinos que assistem a autora (doc.08) – imagem ilustrativa abaixo:"*

Assim postulou *"Garantir a procedência total do pedido para, tornando definitivos os efeitos antecipados ou, caso este não seja concedido, o que se admite somente por amor ao debate, determinar a obrigação da requerida em assegurar o direito de ANDRESSA HELENA FERRARI MENEZES a receber de forma contínua e ininterrupta a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

bomba de insulina e insumos necessários, nos termos da prescrição médica (doc. 03), bem como atualizações necessárias para tratamento da doença aqui litigada (conforme Enunciado da I, II e III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – Enunciado n°.95), garantindo-se o DIREITO À SAÚDE desta demandante; Condenar a requerida em danos morais sofridos pela autora em valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando atender um valor digno a autora e ante o grande poder econômico da requerida;"

Com a inicial vieram os documentos.

Tutela deferida às f. 151/156.

Citada, a demandada apresentou contestação às f. 248/271, na qual alegou *"Inicialmente, importa destacar que a requerente é beneficiária de um plano de saúde empresarial, regulamentado pela Lei nº 9.656/98, firmado com requerida. Assim sendo, considerando que o contrato está vinculado à Lei 9.656/98, informa-se que há previsão expressa que os procedimentos cobertos serão aqueles relacionados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como sendo de cobertura obrigatória, conforme disposto na Cláusula Décima, item 10.1: No entanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualmente através da Resolução Normativa n° 465/2021, impõe as operadoras de planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura de determinados procedimentos, relacionando-os de acordo com a segmentação contratada e, no caso da requerente, o material de Sistema de Infusão Contínua (SIC) não está listado como sendo de cobertura obrigatória. Desta forma, demonstra-se que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde o Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina requerido pela requerente. Assim sendo, a exclusão de procedimentos que não possuem cobertura no Rol da ANS tem expressa previsão contratual, de forma clara e em destaque no contrato firmado entre as partes."* Assim postulou *"Seja reconhecida a inexistência de conduta ilícita praticada pela requerida, bem como de nexo de causalidade e do próprio dano, afastando qualquer responsabilidade civil extrapatrimonial desta. Dessa forma, deve ser julgado totalmente improcedente o pleito de danos Morais."*

Réplica às f. 564/573.

O feito foi saneado às f. 585/587.

Laudo pericial às f. 635/640, do qual as partes se manifestaram.

Laudo complementar às f. 647/652, do qual as partes se manifestaram.

Instadas, as partes apresentaram suas razões finais escritas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de demanda em que a parte autora pretende que a ré seja obrigada a custear tratamento com o fornecimento de bomba de insulina e insumos necessários.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, preenchendo todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim já era, conforme consagrado entendimento doutrinário e jurisprudencial, antes mesmo da Lei n. 9.656/98. Com o advento desta, dúvida nenhuma resta, eis que o referido diploma legal veio expressamente declarar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, consoante se

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

vê de seu atual artigo 35-G.

Outrossim, a ré encontra-se inserida no conceito de fornecedora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Reza o *caput* do art. 3º, da lei consumerista que "fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como seus entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exploração, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Nesse passo, "A leitura pura e simples do *caput* do art. 3º já é capaz de nos dar um panorama da extensão das pessoas enumeradas como fornecedoras. Na realidade são todas pessoas capazes físicas e jurídicas, além dos entes desprovidos de personalidade. Não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo. São fornecedoras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, as sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, os órgãos da Administração direta etc." (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*, Editora Saraiva, 2007, p. 109).

Mencione-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (verbete *atual* n.º 608).

Depreende-se dos autos que a autora é portadora de diabetes tipo 1. Ainda consonante o relatório anexado aos autos pela autora, foi-lhe indicado pela médica de sua confiança tratamento com bombas de insulina e seus rescpetivos insumos.

No que diz respeito ao *método* ou tipo de tratamento apropriado ao caso da autora, conforme recomendado pela médica que a assiste, consigne-se que é inerente à natureza do contrato de plano de saúde a *legítima expectativa do consumidor a um tratamento apropriado e à preservação dos riscos a sua saúde e de sua família e dependentes*.

Ademais, extrai-se do laudo pericial de f. 635/340:

> Dada a complexidade do quadro clínico da paciente, marcado por instabilidade glicêmica, complicações vasculares como retinopatia diabética e o risco de hipoglicemia fatal, torna-se **imprescindível a adoção URGENTE da terapia com bomba de insulina como alternativa ao tratamento** convencional (e falho) de múltiplas aplicações de insulina. A bomba de insulina pode oferecer um controle mais preciso da glicemia, reduzindo drasticamente os riscos associados e melhorando significativamente sua qualidade de vida, haja vista que fornecendo uma administração contínua e personalizada de insulina, ajudaria a manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis, reduzindo significativamente as flutuações que podem levar a complicações agudas e crônicas: isso não apenas melhoraria o controle glicêmico, mas também pode reduzir o risco de desenvolver ou progredir para outras complicações relacionadas ao diabetes, como problemas renais, neuropatia e doenças cardiovasculares dentro outras.
>
> 1. Considerando-se o diagnóstico da periciada, trata-se de um caso de urgência ou emergência ou de um caso com tratamento a ser agendado com um adequado preparo pré-operatório?
> ***Resposta:*** *Sim, trata-se de um caso de urgência.*
>
> 4. A terapêutica com medicamento de uso de forma ambulatorial tem cobertura contratual? Existe cláusula específica de exclusão contratual para medicamentos de uso ambulatorial?
> ***Resposta:*** *conforme consta nos autos, não há cláusula contratual que justifique de forma suficiente sua limitação ou exclusão de cobertura.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

5. É possível afirmar que existe em medicina baseada em evidência confirmação de que o uso do material solicitado é seguro, e que reduza significativamente a morbidade e a mortalidade quando comparado com o tratamento ofertado pela Unimed de acordo com as regras da ANS?
Resposta: *Sim, existem evidências com base em estudos clínicos e revisões sistemáticas que confirmam a segurança e a eficácia do uso da bomba de insulina no tratamento do diabetes tipo 1, culminando em melhor controle glicêmico, redução das flutuações nos níveis de glicose no sangue, menor risco de hipoglicemia e melhora na qualidade de vida dos pacientes quando comparado ao tratamento com múltiplas injeções diárias de insulina (tratamento ofertado pela Unimed).*

A finalidade principal do contrato de plano de saúde é fornecer ao beneficiário tratamento adequado e condizente ao seu quadro clínico devendo, por conseguinte, a prestadora oferecer os meios necessários para o resguardo da saúde do beneficiário. Nesse contexto, a operadora do plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não os procedimentos, técnicas, instrumentos e exames necessários ao tratamento da enfermidade prevista no rol de coberturas, posto que o médico é o responsável pela orientação terapêutica. Assim, em havendo previsão contratual para a cobertura de tratamento da doença de que padece a contratante, tal como prescrição médica para que seja adotado determinado procedimento visando a cura, a recuperação ou a melhora do estado de saúde, é dever do plano de saúde autorizar o procedimento.

À vista disso, é de se reconhecer que a atitude da ré busca tolher o profissional de saúde de escolher a alternativa que melhor convém ao tratamento de sua patologia, em interferência manifestamente arbitrária. A propósito, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, quando foi relator do REsp. 668.216 no âmbito do STJ, asseverou:

(...) Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor (...).

Outrossim, em que pese sua premissa da ausência de obrigação de custeio do tratamento que não consta na lista da ANS, faz-se imperioso elucidar que não excluindo o contrato o tratamento da doença diagnosticada, não podem, igualmente, ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura, ao tratamento e ao bem estar do paciente, especialmente quando não compete à operadora do plano de saúde a indicação do método mais eficaz ao atendimento das necessidades particulares do paciente, incumbindo ao médico adjunto à parte essa tarefa.

Não obstante as alegações da ré de que o medicamento/tratamento/procedimento requerido não se encontra previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, ressoa majoritário o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual o rol da ANS é meramente exemplificativo, e, por isso, o plano de saúde está obrigado a autorizar o tratamento necessário ao diagnóstico e a adequada orientação terapêutica, sob pena de frustração da finalidade precípua da relação contratual firmada entre as partes, que é a saúde do usuário:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

"O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura" *(Resp. nº 668.216/SP, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007).*

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências – SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA.TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação cominatória. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3ª Turma, DJe de 02/10/2017). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1905033 SP 2020/0292154-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

Em plena consonância está a pacífica e consolidada jurisprudência pátria:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA A PACIENTE COM DIABETES – ROL DA ANS – LEI Nº 9.566/98, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.454/22 – REFERÊNCIA BÁSICA (ART. 10, § 12) – POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL (ART. 10, § 13, II) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da promulgação da Lei 14.454, de 21/09/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.566/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, passou a constituir a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, devendo o tratamento prescrito por médico que não esteja no rol em questão ser autorizado quando preenchidos os requisitos constantes dos incisos I e II do § 13 do referido dispositivo, como no caso. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1420542-78.2022.8.12.0000,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 04/02/2023, p: 07/02/2023).

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO PARA FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS – AUTOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – LAUDO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO, ANTE A GRAVIDADE DO QUADRO DO PACIENTE –NECESSIDADE DE CONTROLE INTENSO DA DOENÇA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cabe antecipar os efeitos da tutela. 2. Presente a plausibilidade do direito e o risco de dano iminente, porquanto comprovada a necessidade e indicação médica para o paciente receber o tratamento necessário, cuja recusa pode agravar suas condições de saúde, aliado ao fato de que, conforme relatório médico, não teve êxito o tratamento médico do agravado, e por conta de seu estado de saúde, necessita da bomba de infusão de insulina, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. 3. Há que se ressaltar que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica. Comprovada a necessidade do procedimento indicado, não prevalece a cláusula contratual de limitação da cobertura, porque deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao consumidor. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1413039-11.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 21/01/2020, p: 22/01/2020).*

Destarte, havendo a necessidade e a fundamentada recomendação, comprovada por laudo médico, de que o método melhor indicado ao tratamento da autora, levando em conta suas especificidades, é, de fato, o tratamento por meio de bomba de insulina e seus respectivos insumos, não se encontra no poder da ré limitá-lo com base no argumento esboçado na contestação.

Feitas estas considerações, com fulcro no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, considero ser abusiva qualquer cláusula que exclua a responsabilidade do plano de saúde em fornecer método imprescindível para tratamento necessário à garantia da saúde da autora, visto que veda garantia básica do consumidor. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO ESPECIFICADA. SÚMULA Nº 284/STF. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O TRATAMENTO RECOMENDADO. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578.134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 11/11/2014).

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE DAR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em princípio, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado. [...] (REsp 874.976/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, apenas a recusa injustificada é capaz de ensejar a condenação por dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE DE STENT CORONÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, em que o paciente com doença coronária grave e risco de morte necessitava de urgência no procedimento para colocação de stents, o STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que nas relações contratuais, como na espécie, os juros de mora são devidos desde a citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 972.764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação ordinária que objetiva a cobertura de medicamento e a compensação por danos morais. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 4. Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 5. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela ausência de prova de prejuízo à personalidade da agravante com a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer o medicamento requerido. A revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Em virtude do decaimento do pedido de danos morais da parte autora, é de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.656.393/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

Na espécie, tendo em vista que a recusa da parte demandada é decorrente em interpretação diversa do contrato, havendo, portanto, justificativa para a sua recusa, não há que se falar em danos morais.

Isso posto, resolvendo o mérito da demanda na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para convalidar a tutela antecipada liminarmente concedida às f. 151/156, a fim de que a ré autorize e custeie o tratamento por meio de bomba infusora de insulina, bem como todos os insumos prescritos no documento de f. 40, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), esta limitada a trinta dias, enquanto for necessário e prescrito pela médica assistente da autora. Considerando a sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Determino o levantamento dos honorários periciais em favor do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.

perito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Campo Grande, data da assinatura digital.

Fábio Henrique Calazans Ramos
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2024 às 15:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852178-11.2022.8.12.0001 e código p5fldp0F.